

精神医学総論

- ・ 精神症状学
- ・ 疾病分類学

最初にみなさんにいくつか質問します。

答えはこれからの

講義で話しますので、わからなくて当然ですが、

記憶の助けにもなるので、少し頭の体操をしておきましょう。

昨年のわが国の自殺者数は何人ぐらい？

2千人？

2万人？

20万人？

遺書から推定した自殺の最大の原因は？

健康問題？

経済問題？

家庭問題？

わが国における5大疾病とは？

**不安やうつには身体症状が伴います。
具体的にはどんな症状？**

**実際に存在する対象を間違って別のものと知覚することを
何というか？**

**実際には存在しない対象を存在するように知覚することを
何というか？**

間違っていて、確信され、訂正不可能である思考の
障害を何というか？

うつ病では妄想がみられることはない。
これは正しいか？

合理的な自殺はあり得るか？

19歳、男性。

もともと、穏やかな人柄。徐々に表情が
乏しくなり、独り言が目立つようになってきた。
ある日、人の悪口を言うな、と突然叫び、家を飛び出した。

（正常か異常か？）

21歳、女性。

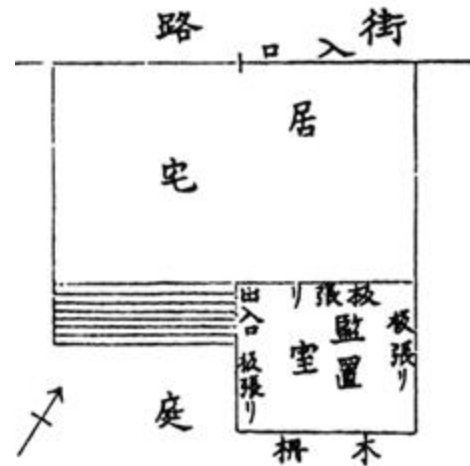
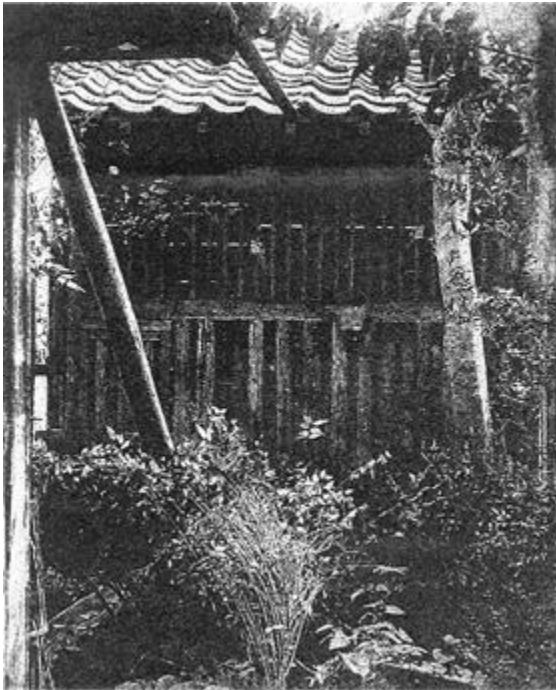
もともと、友人も多く、活発。

胃痛で受診した結果、スキルス胃がんであることがわかり伝えられた。予後は1年程度と予想されたが、家族のみに伝えられた。

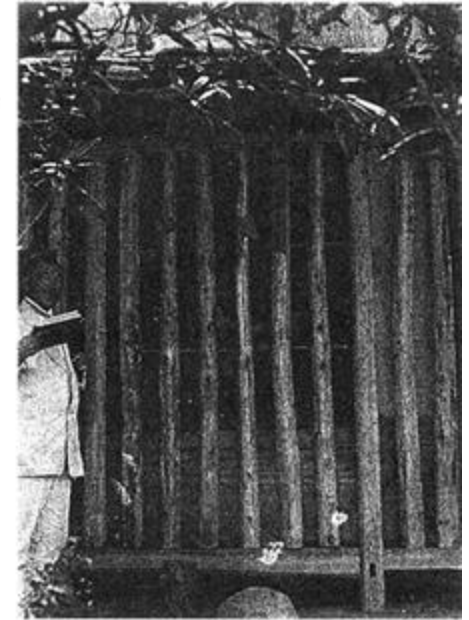
その後、徐々に口数が減り、友人と会うのも億劫になってきた。胃がんのせいか食欲も落ち、体重もここ3か月で5kg以上減少。最近では悲観的な言葉が多く、死にたいと漏らすことが増えた。

(正常か異常か?)

これは何でしょうか？



呉・樫田：第64例付図



ヒント：「わが国十何万の精神病者はこの病を受けたるの不幸のほか
この国に生まれたるの不幸を重ねるものというべし」

精神医学総論

- 精神症状学
- 疾病分類学

私たちの目標

こういった専攻にすすまれても、人のこころや精神の問題に触れることは日常茶飯です。
最低限、「病を抱えた人」を診る医師として必要な知識、技能、態度を身につけていただくことを目指しています。

名市大精神科の教育体制

- ・ M4 系統講義
- ・ M5 Bed Side Learning（大学、精神病院）
- ・ M6 選択性臨床実習（総合病院、国立がん研究セなど）
- ・ 卒後ローテーション研修（多頻度精神疾患の受け持ち）

私たちの目標：例えば皆さんが内科医/外科医になったとき---

- ・ 担当していた慢性呼吸不全の72歳の患者さんの様子が最近変化してきた。急に興奮したり、苦しくなるはずなのに酸素マスクを自分で外したりするようになった。

この患者さんには何が起きているのか？

- ・ 強い食欲不振で受診された患者さんの問診をしているとその患者さんは「リストラされてもう希望がないんです。

死んでしまいたい---。」と話した。担当医としてこの患者さんに何をすべきか？

- ・ 患者さんは悪い結果であっても、すべての医学的情報を知りたいと希望されている。治癒が望めない進行がんであることをどのように伝えるか？伝えた後、どのようにケアするか？

- ・突然の動悸、めまいで救急車で中年の男性が搬送されてきた。諸検査の結果、特に異常は認められなかった。カルテをみると3週間前にも同様のエピソードがみられていた。

不安がる患者さんに何をすべきか？

- ・意識障害で若い女性が救急搬送された。意識障害の原因は大量服薬であることが判明した。経過観察のみで意識は戻ったため帰宅させた。1週間後、今度は多発外傷で救急搬送された。飛び降りによる自殺であり、救命することはできなかった。

- ・わが国における自殺率は1998年以降3万人を超えていた。2012年に2万人台になり、徐々に低下していたが、2020年再度上昇に転じた。中高年に多く、遺書の内容で最も多いのは健康問題である一方、実際の原因はうつ病であることが最も多い。

あらゆる世代でこころの病が急増！

児童虐待



うつ病・自殺



身体疾患に伴う不安・うつ 災害後のPTSD



認知症



うつ病とは？

どのような状態が
想像してみましょう

*抑うつ気分

睡眠障害

食欲低下・亢進

*興味・喜び減退

思考・集中力低下

自責感

***いずれか必須
5項目以上
2週間以上持続**

倦怠感・
意欲低下

焦燥感・制止

希死念慮

うつ病とは？

「こころが激痛」
を感じている状態

*抑うつ気分

睡眠障害

食欲低下・亢進

*興味・喜び減退

思考・集中力低下

自責感

***いずれか必須
5項目以上
2週間以上持続**

倦怠感・
意欲低下

焦燥感・制止

希死念慮

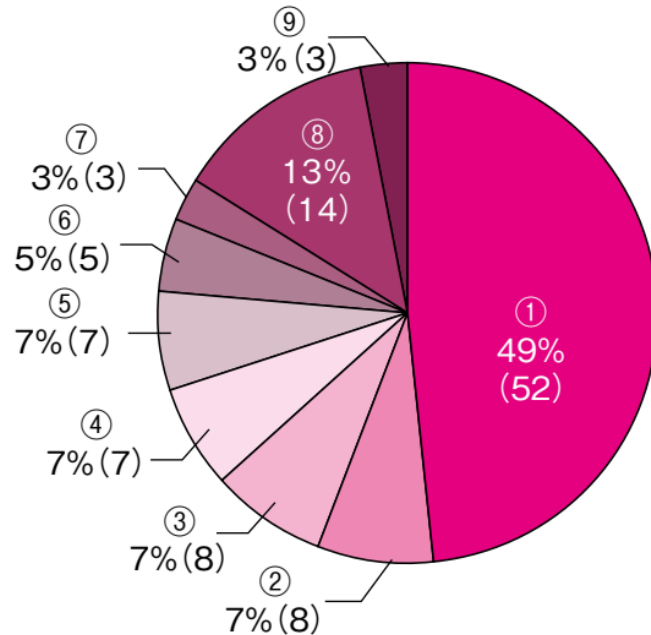
身体疾患と自殺

河西千秋 患者安全推進ジャーナル 2016

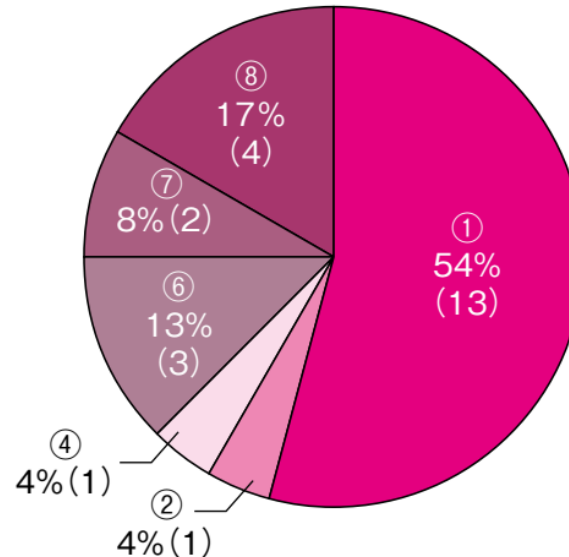
Q1.主たる身体疾患病名

- ①悪性腫瘍 ②消化器疾患 ③脳神経疾患 ④整形外科疾患 ⑤呼吸器疾患 ⑥循環器疾患 ⑦腎泌尿器疾患 ⑧その他
⑨無回答、不明

A. 精神科病床のない一般病院
<全自殺事故件数 107 件>



B. 精神科病床のある一般病院（精神科病床以外）
<全自殺事故件数 24 件>



わが国の一般病院入院患者の自殺事例が罹患していた
身体疾患は、がんが約半数と最多

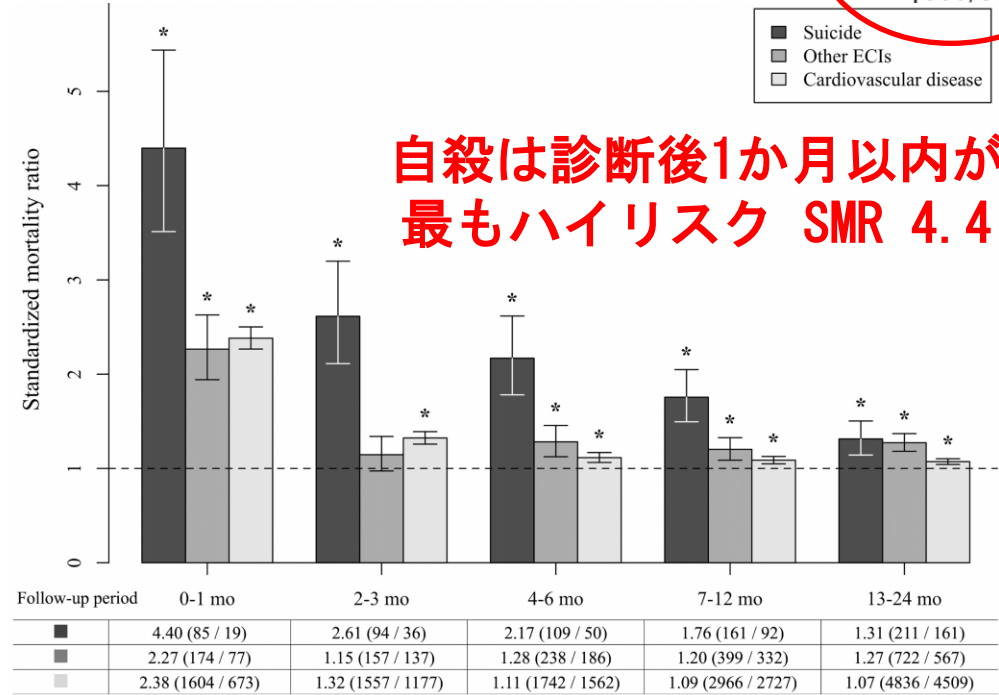
がん患者の自殺と心血管死-日本

Kurisu K, Akechi T et al, Cancer Med 2022

対象 がん登録（2016-7年、がん患者 1,070,876人）

TABLE 2 Standardized mortality ratio, observed count, and expected count of deaths by suicide, other externally caused injuries, and cardiovascular disease within the 2-year follow-up period

	No. of patients	SMR (95% CI) [Observed count/Expected count ^a]		
		Suicide	Other ECIs	CVD ^b
All	1,070,876	1.84 (1.71–1.99) [660/358]	1.30 (1.24–1.37) [1690/1298]	1.19 (1.17–1.21) [12,705/10,649]



自殺は診断後1か月以内が
最もハイリスク SMR 4.4

心血管死も診断後1か月以内が
最もハイリスク SMR 2.4

Conclusion: Suicide prevention countermeasures for patients with cancer, especially those with advanced disease immediately after diagnosis, are warranted.

ScienceとArt

Science

- 疾病を持つ特定の臓器 (Disease)
- 身体を扱う (客観的対象)
- 普遍的である
- 分析する
- cureが目標
- 冷静さが必要

Art

- 病を持つ人間が対象 (Illness)
- **こころ**を扱う (主観的対象)
- 個別的である
- アプローチする
- **care**が目標
- **温かさと思いやり**が必要

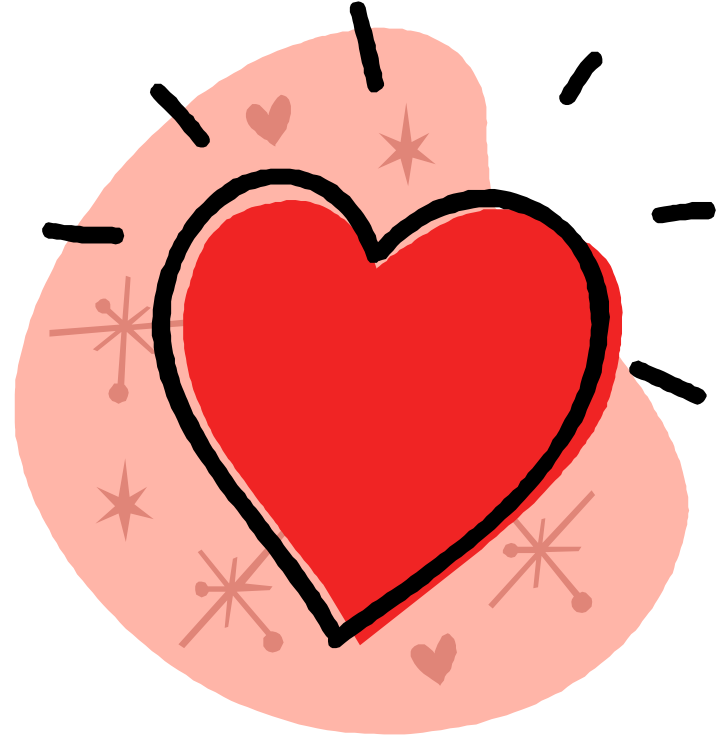
disease

dis 分離する、欠く

ease 快適さ、安楽、安心

医療の本質として、easeの回復はとても重要

精神医学とは？



精神現象、つまり気分・感情、知覚、思考、
意欲、記憶、知能などを扱う医学である

精神状態の正常・異常

Sims ACP, Symptoms in the mind

価値的正常（異常）：社会的に望ましいと考えられる状態

統計的正常（異常）：その集団中の平均値や中央値の周囲の値をとる状態

個体的正常（異常）：個人のある時点の状態が、その個人の通常の状態から偏りがない状態

- ・ いずれの軸をあてはめるかに規則はない
- ・ 正常と異常の区分点も実は明確ではない

臨床的には、正常か異常かという視点よりもむしろ、
「患者さんが苦痛」を感じており、「ケアが必要か否か」
で判断することが有用

こころの病と著名人

ムンク

芥川龍之介

ヘミングウェイ

カレン（カーペンターズ）

堂本剛

チャーチル

トルストイ

レーガン

統合失調症

統合失調症

双極性障害

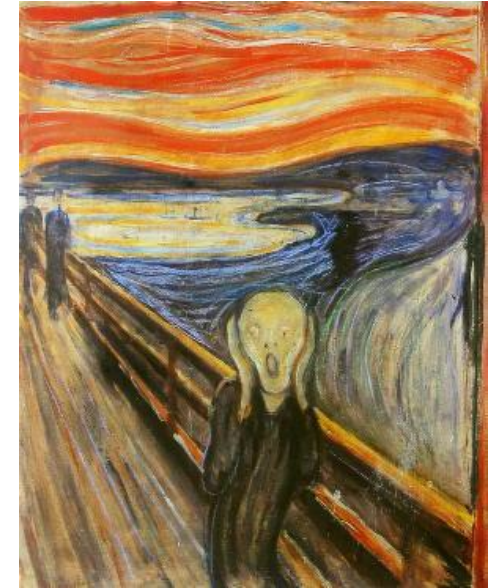
摂食障害

パニック障害

うつ病

うつ病

認知症



精神疾患加え「5大疾病」に 厚労省、医療計画で方針

2011年7月7日 朝日新聞

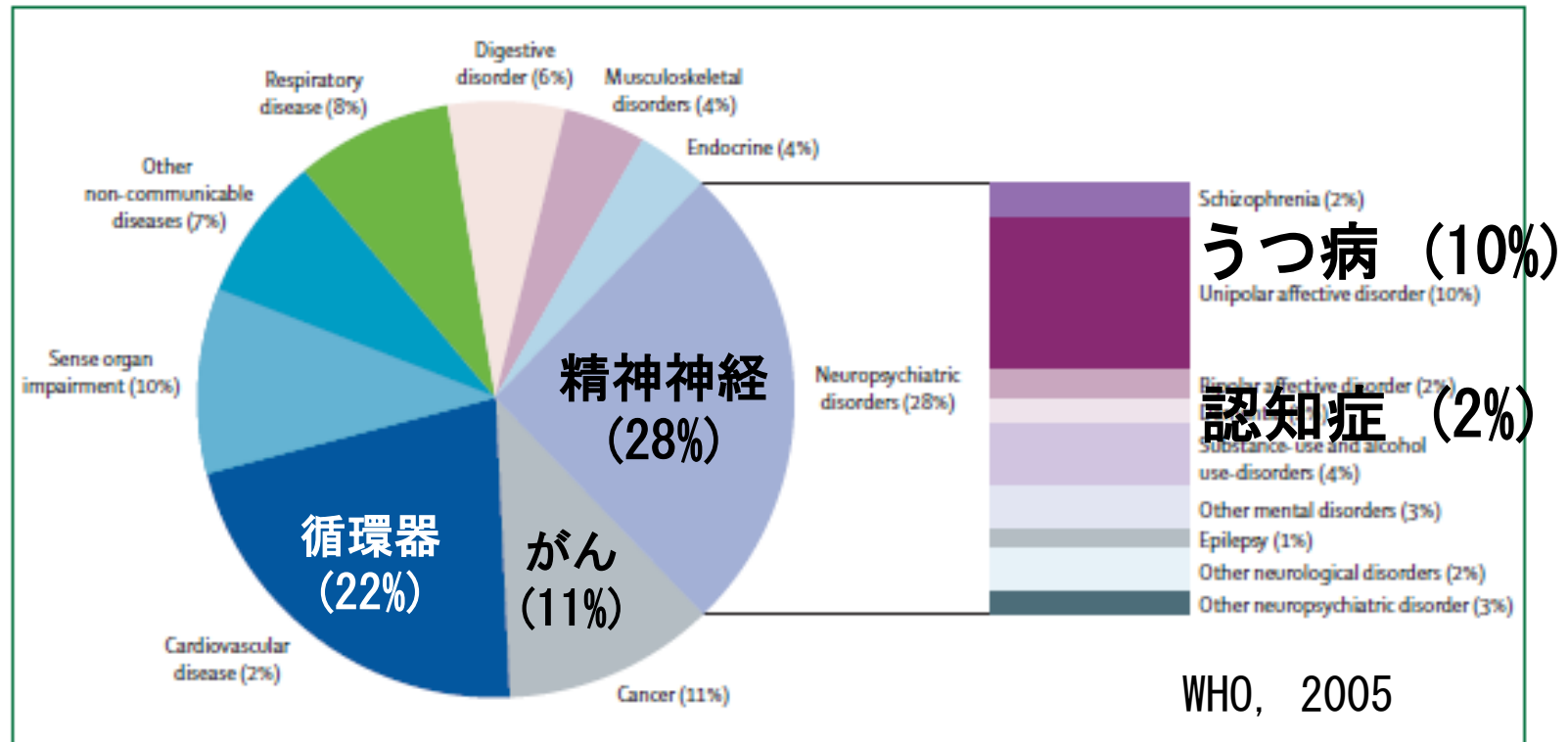
厚生労働省は7日までに、地域医療の基本方針となる医療計画に盛り込むべき疾病として指定してきたがん、脳卒中、心臓病、糖尿病の四大疾病に、**新たに精神疾患**を加えて「**5大疾病**」とする方針を決めた。

職場での**うつ病**や高齢化に伴う**認知症**の患者数が年々増加し、国民に広く関わる疾患として重点的な対策が必要と判断した。既に社会保障審議会医療部会で了承されており、厚労省は医療計画に関するガイドラインに記載し、12月をめどに各都道府県に示す方針。多くの都道府県で2013年度以降の医療計画に反映させる。

医療計画は都道府県が作成するもので、5年ごとに更新

精神疾患による甚大な社会的損失

DALYs (Disability Adjusted Life Years; 障害調整生命年)
生命の死と生活障害を考慮した病気の社会負担を示す指標



精神神経疾患は、がん・循環器疾患と並ぶ三大疾患

No health without mental health (Prince M et al, Lancet, 2007)

うつ病による健康損失

今後20年間増加し、2030年には人類全体で最大の健康損失の原因となると予想されている

Figure 27: Ten leading causes of burden of disease, world, 2004 and 2030

2004 Disease or injury	As % of total DALYs	Rank		Rank	As % of total DALYs	2030 Disease or injury
Lower respiratory infections	6.2	1		1	6.2	Unipolar depressive disorders
Diarrhoeal diseases	4.8	2		2	5.5	Ischaemic heart disease
Unipolar depressive disorders	4.3	3		3	4.9	Road traffic accidents
Ischaemic heart disease	4.1	4		4	4.3	Cerebrovascular disease
HIV/AIDS	3.8	5		5	3.8	COPD
Cerebrovascular disease	3.1	6		6	3.2	Lower respiratory infections
Prematurity and low birth weight	2.9	7		7	2.9	Hearing loss, adult onset
Birth asphyxia and birth trauma	2.7	8		8	2.7	Refractive errors
Road traffic accidents	2.7	9		9	2.5	HIV/AIDS
Neonatal infections and other ^a	2.7	10		10	2.3	Diabetes mellitus
COPD	2.0	13		11	1.9	Neonatal infections and other ^a
Refractive errors	1.8	14		12	1.9	Prematurity and low birth weight
Hearing loss, adult onset	1.8	15		15	1.9	Birth asphyxia and birth trauma
Diabetes mellitus	1.3	19		18	1.6	Diarrhoeal diseases

WHO (2008) The global burden of disease: 2004 update.
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html.

日本の健康損失-DALYs

Nomuara S et al, Lancet 2017

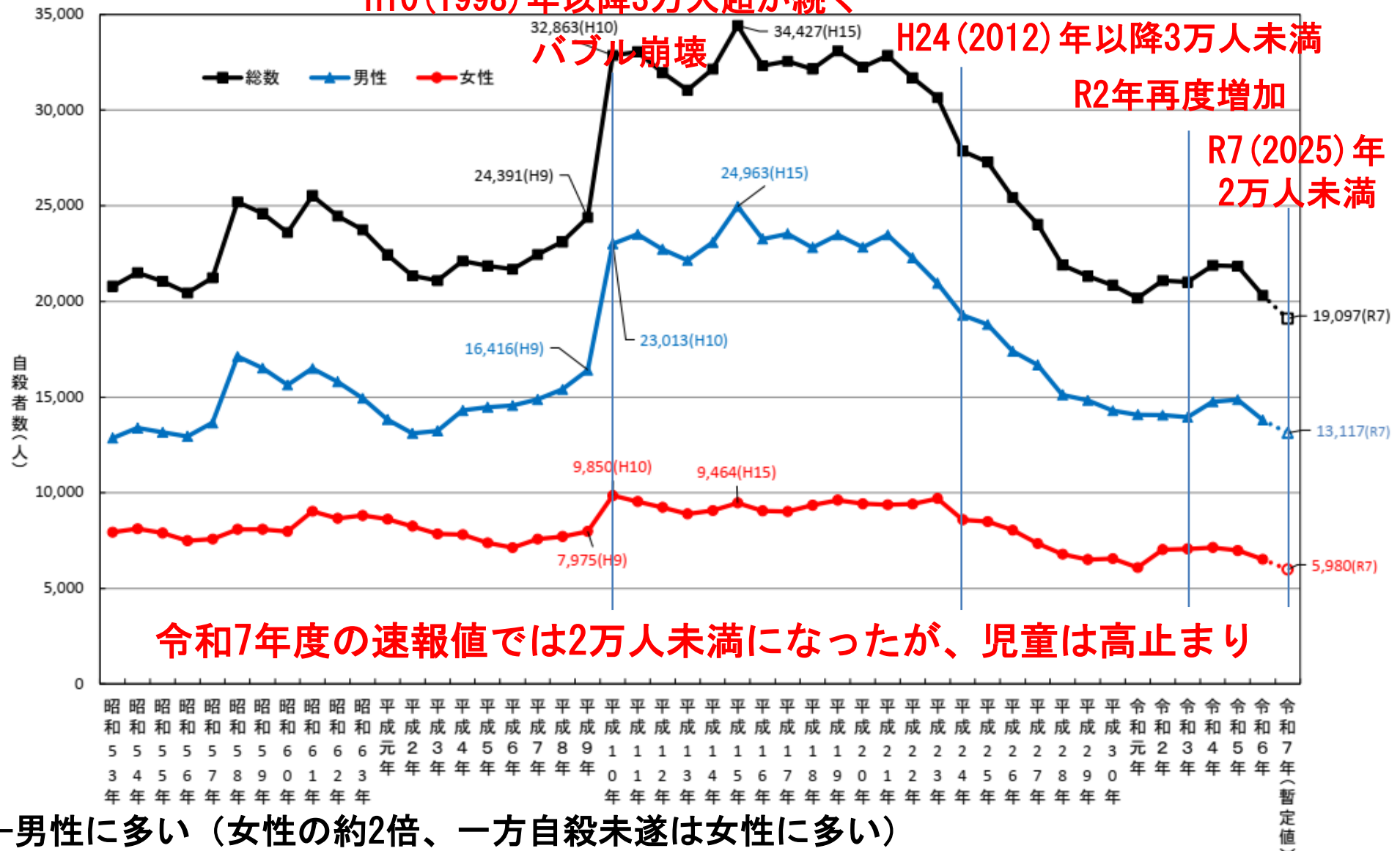
Leading causes 2015

- 1 Ischaemic heart disease
- 2 Low back & neck pain
- 3 Sense organ diseases
- 4 Cerebrovascular disease
- 5 Alzheimer's disease
- 6 Lower respiratory infections
- 7 Lung cancer
- 8 Self-harm
- 9 Stomach cancer
- 10 Colorectal cancer
- 11 Depressive disorders
- 12 Skin diseases
- 13 Chronic kidney disease
- 14 Diabetes
- 15 Liver cancer
- 16 Oral disorders
- 17 Falls
- 18 Other musculoskeletal disease
- 19 Migraine
- 20 COPD

1. 虚血性心疾患
2. 腰痛、頸部痛
3. 糖尿病
4. 脳血管疾患
5. アルツハイマー病
6. 高血圧
7. 肺がん
8. 自傷
9. 胃がん
10. 大腸がん
11. うつ病
12. 認知症
13. がん
14. 脳梗塞
15. 肝がん
16. 心臓病
17. 転倒

わが国の自殺者数の年次推移等-令和7年まで

H10(1998)年以降3万人超が続く



- 男性に多い(女性の約2倍、一方自殺未遂は女性に多い)
- 年齢: 40-70代が多い
- 原因(遺書から推定): 健康問題>経済・生活問題>家庭問題>勤務問題

認知症患者

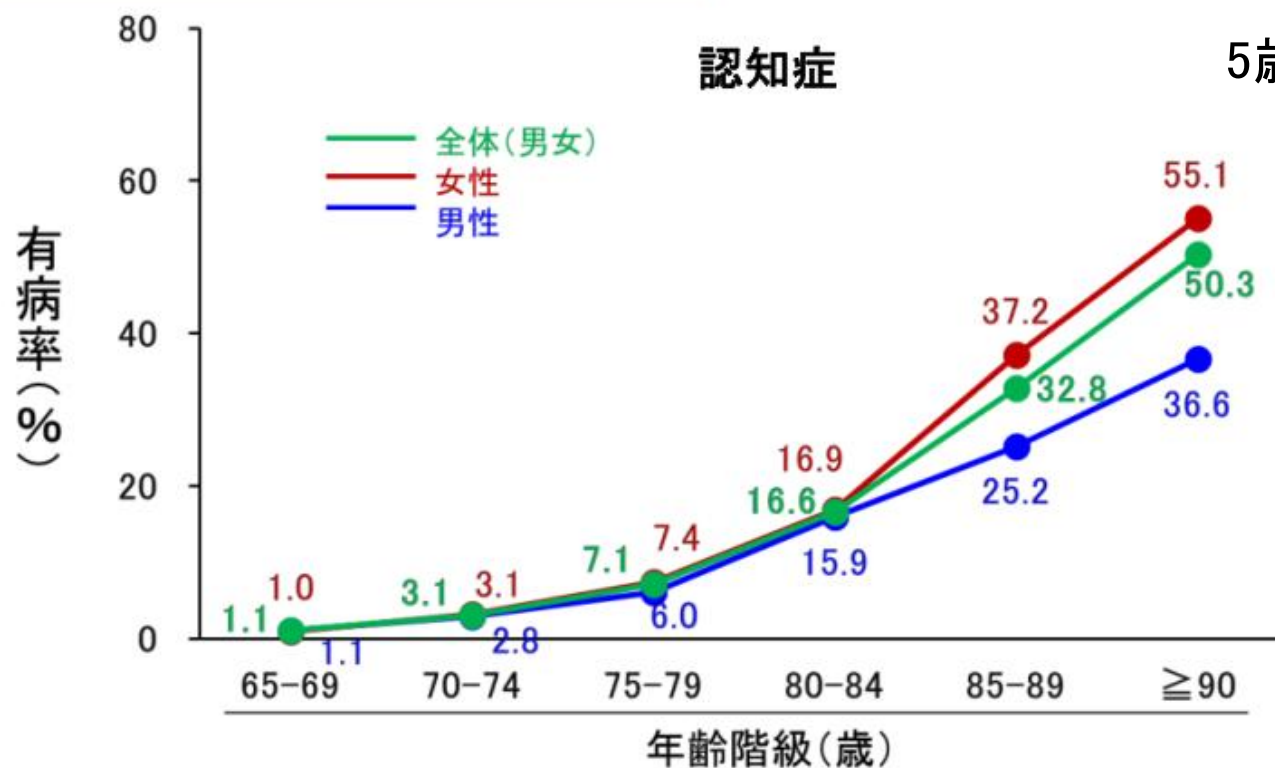
厚生労働省

<https://www.mhlw.go.jp/content/001279920.pdf>

高齢者数と有病率の将来推計

年	令和4年 (2022)	令和7年 (2025)	令和12年 (2030)	令和22年 (2040)	令和32年 (2050)	令和42年 (2060)
認知症高齢者数	443.2万人	471.6万人	523.1万人	584.2万人	586.6万人	645.1万人
高齢者における 認知症有病率	12.3%	12.9%	14.2%	14.9%	15.1%	17.7%

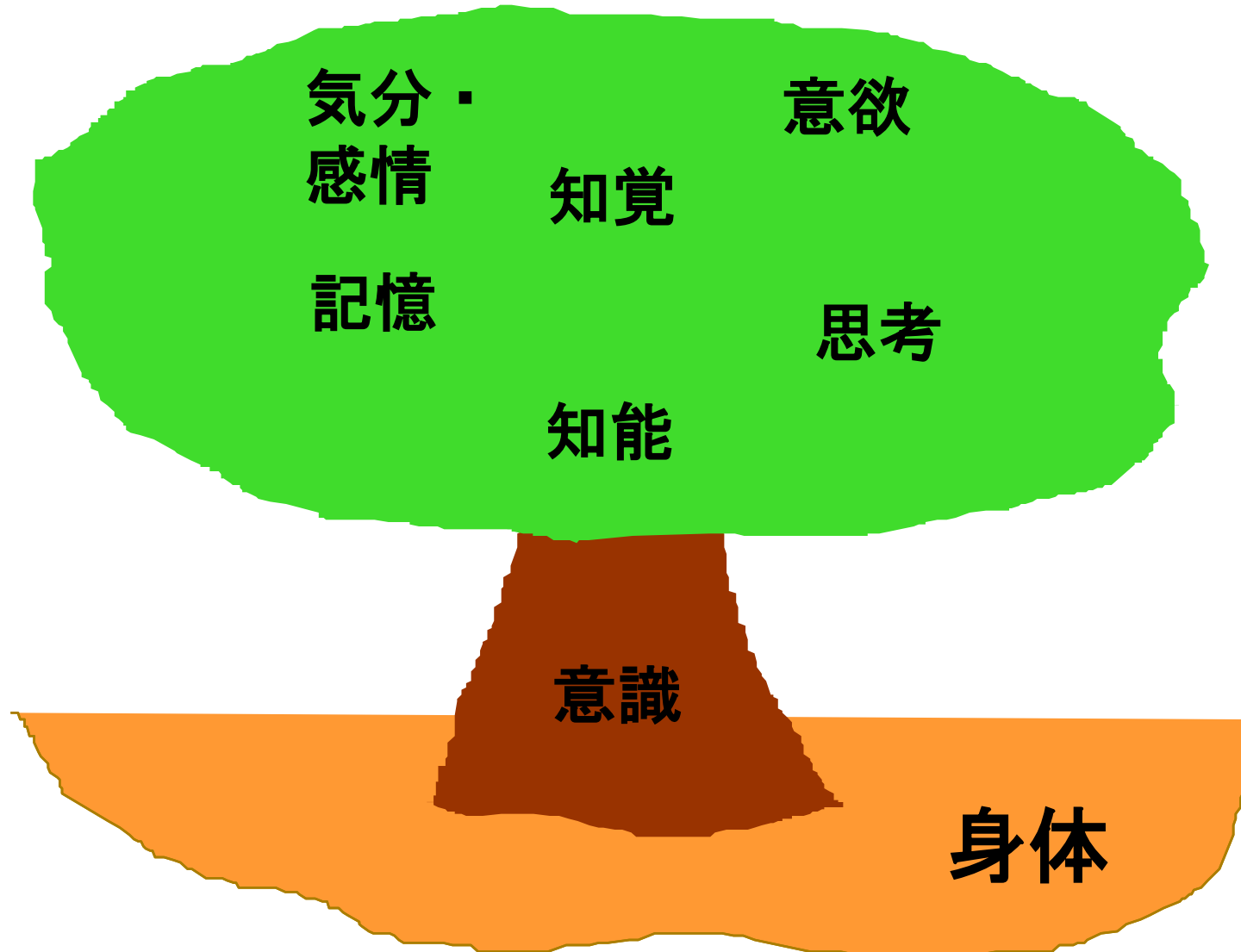
年齢階級別の有病率(2022年時点)



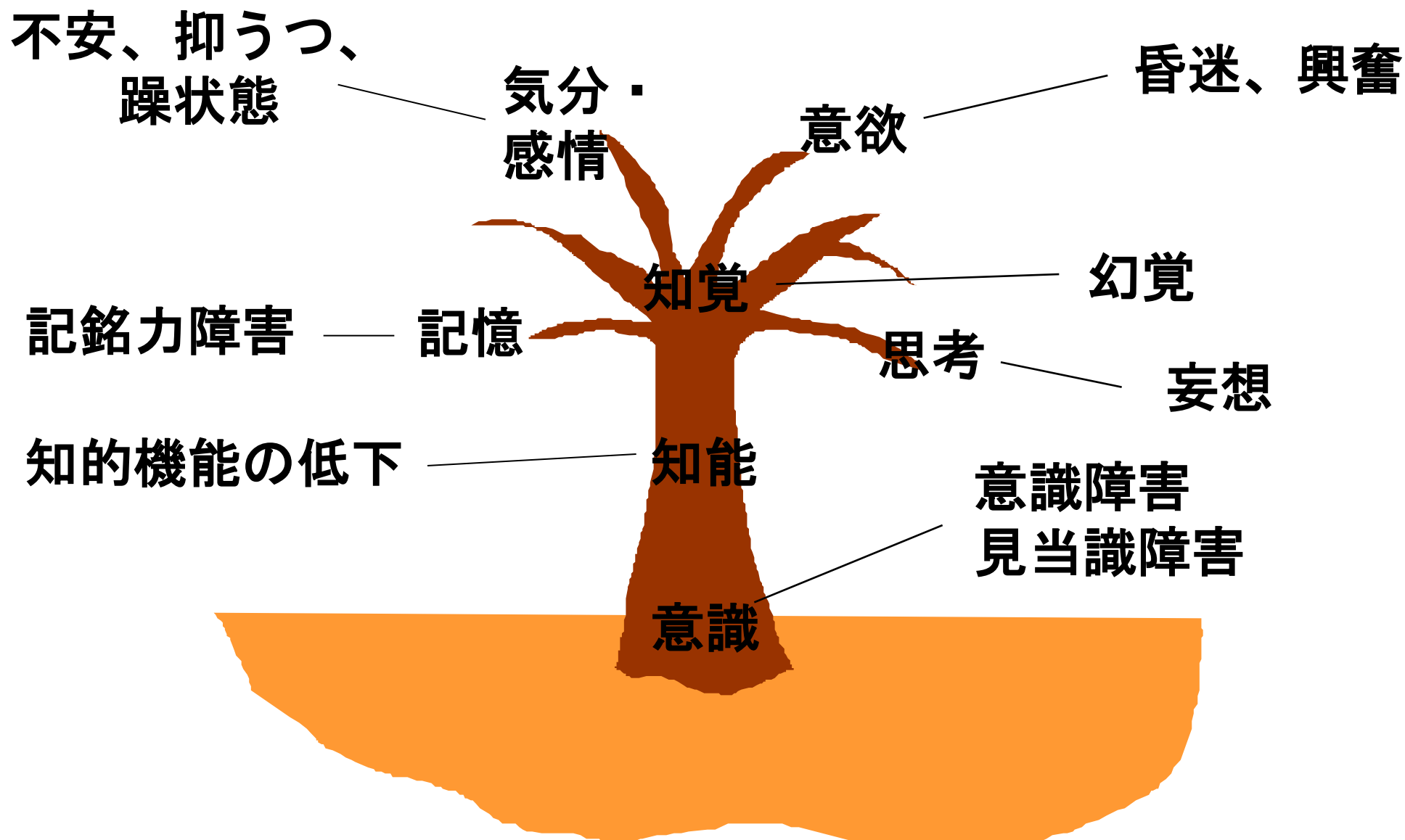
精神医学総論

- 精神症状学
- 疾病分類学

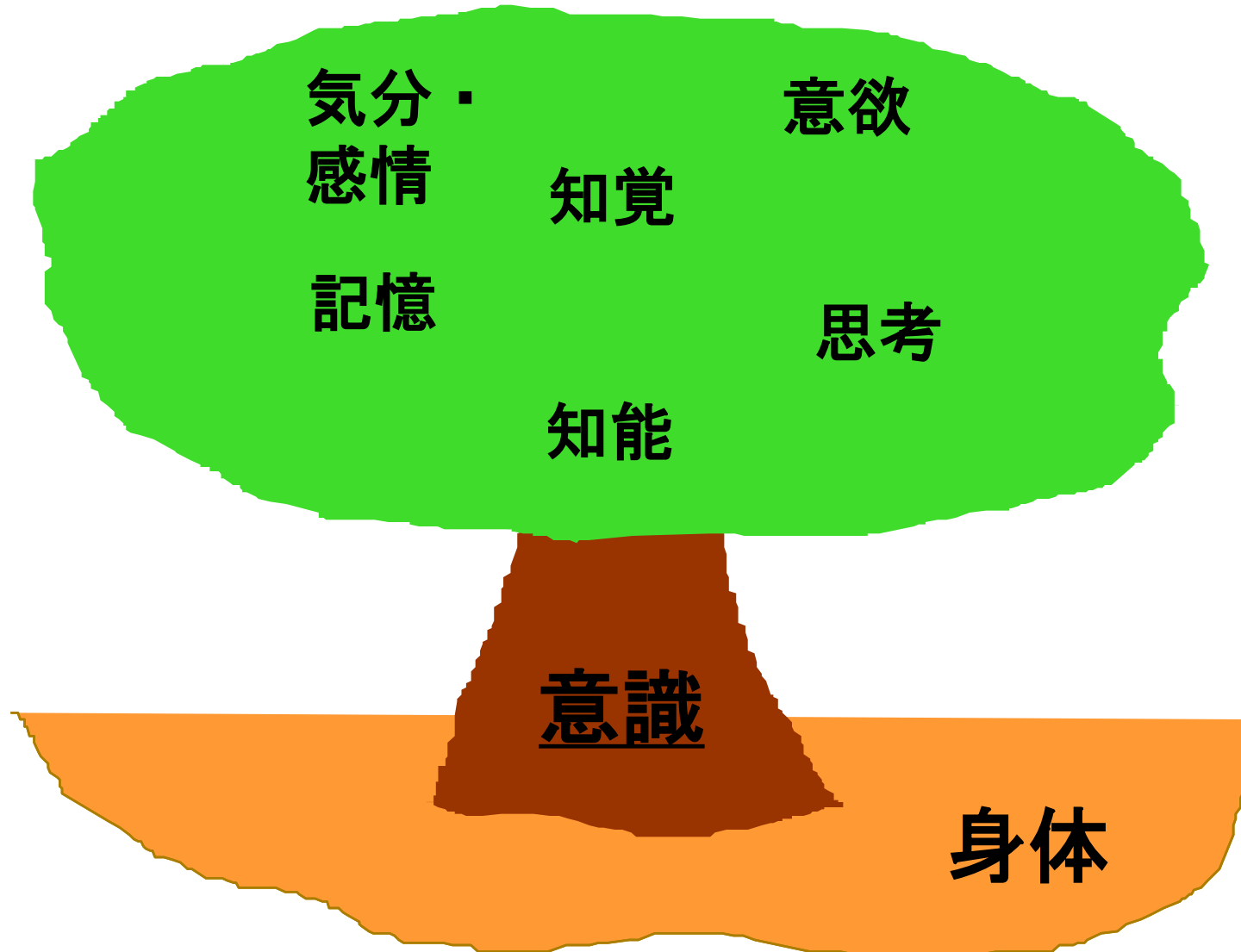
ヒトの精神機能



精神機能の障害と代表的な症状



ヒトの精神機能



意識とその障害

- 意識とはそもそも多義的な概念である
 - 生物学的：脳の覚醒状態
 - 心理学的：自分自身や周囲に対する認知の状態
- 一般的には、意識が保たれている状態とは「外界の状態や自分の状態を良く分かっている状態」

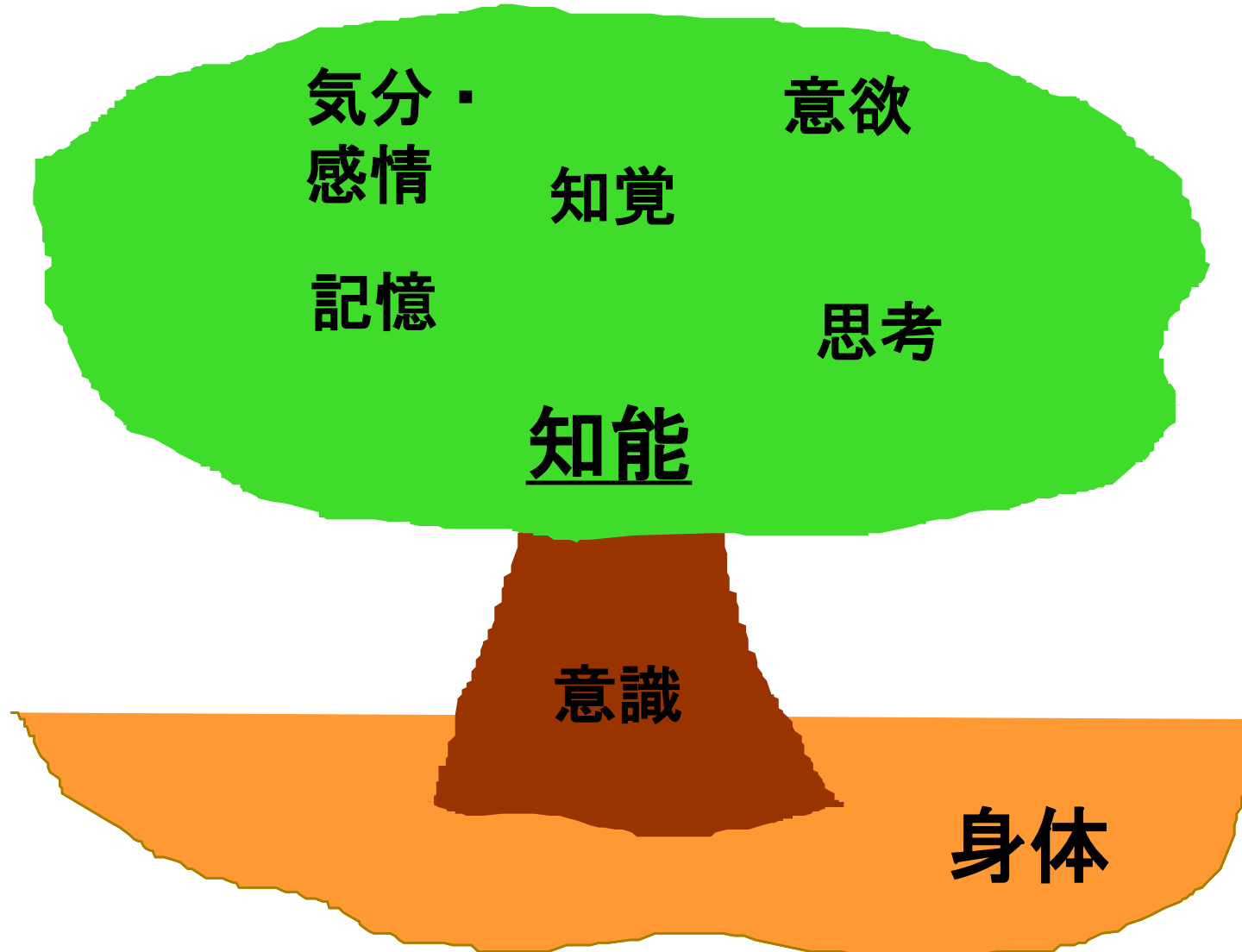
見当識とその障害（失見当識）

見当識：自分の置かれた状況（時、場所、周囲の人物など）
についての認知

- 時間の見当識
 - － 「今日は何月何日ですか」
- 場所の見当識
 - － 「ここはどこですか」
- 人物の見当識
 - － 「この人は誰ですか」

見当識障害は、意識障害、記憶障害等でみられる

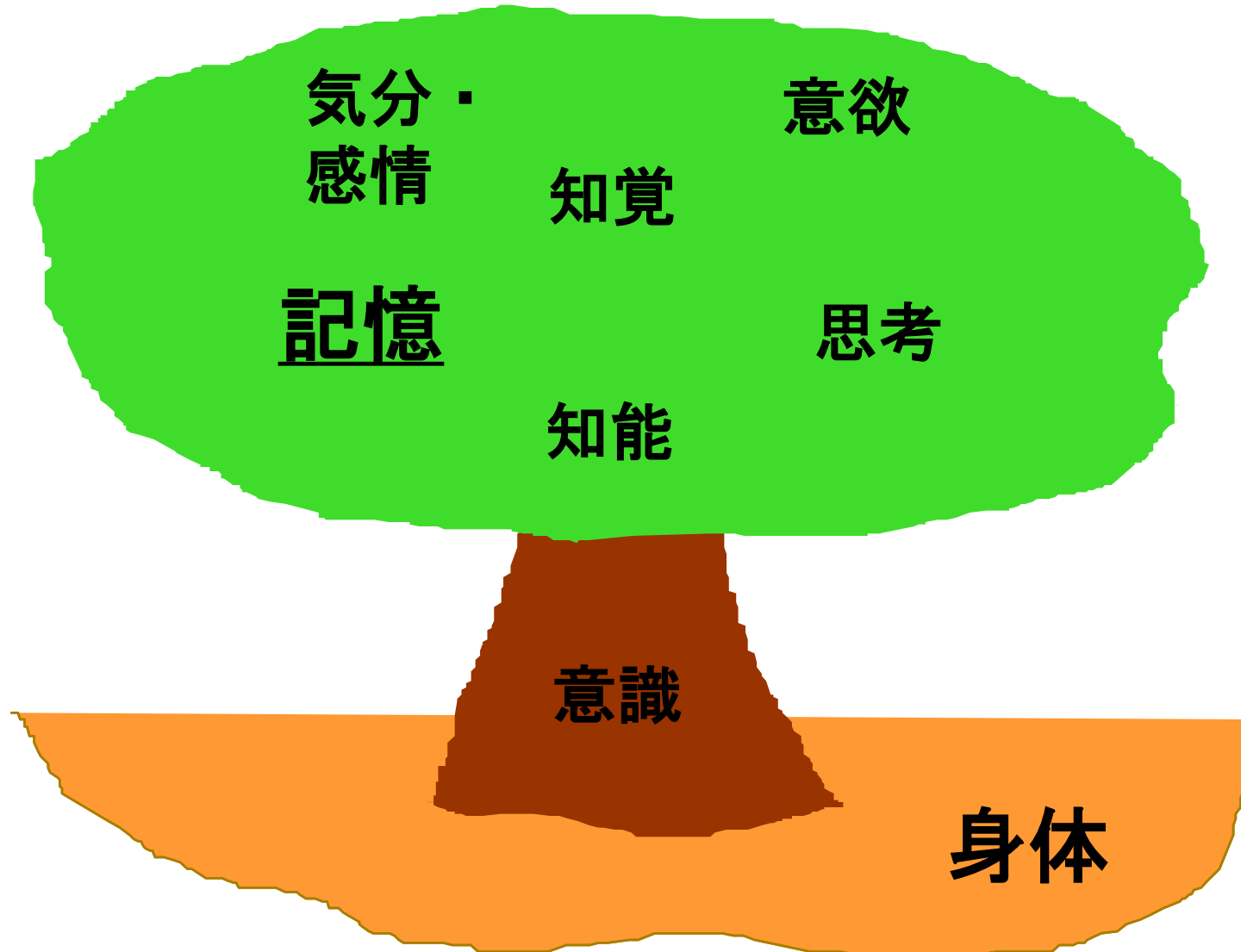
ヒトの精神機能



知能とその障害

- 知能とは「新しい課題を解決する能力」
認知、見当識、記憶機能、知識、判断など
 - 知能の発育の障害＝知的障害（精神遅滞）
 - いったん発達した知能が後天的な原因に基づき低下＝認知症

ヒトの精神機能



記憶

- ・ 記銘、保持、想起・追想からなる機能
- ・ 短期記憶（記銘）と長期記憶（想起・追想）
- ・ 長期記憶：意味記憶（一般的な知識、例：大根は野菜だ）
エピソード記憶（自己の生活体験の思い出、
例：昨日小学校の同級生と駅でばったり出会った）

記憶の障害（健忘）

健忘

－ 逆行性健忘

障害発生以前の出来事までさかのぼって想起できない

過去



－ 前向性健忘

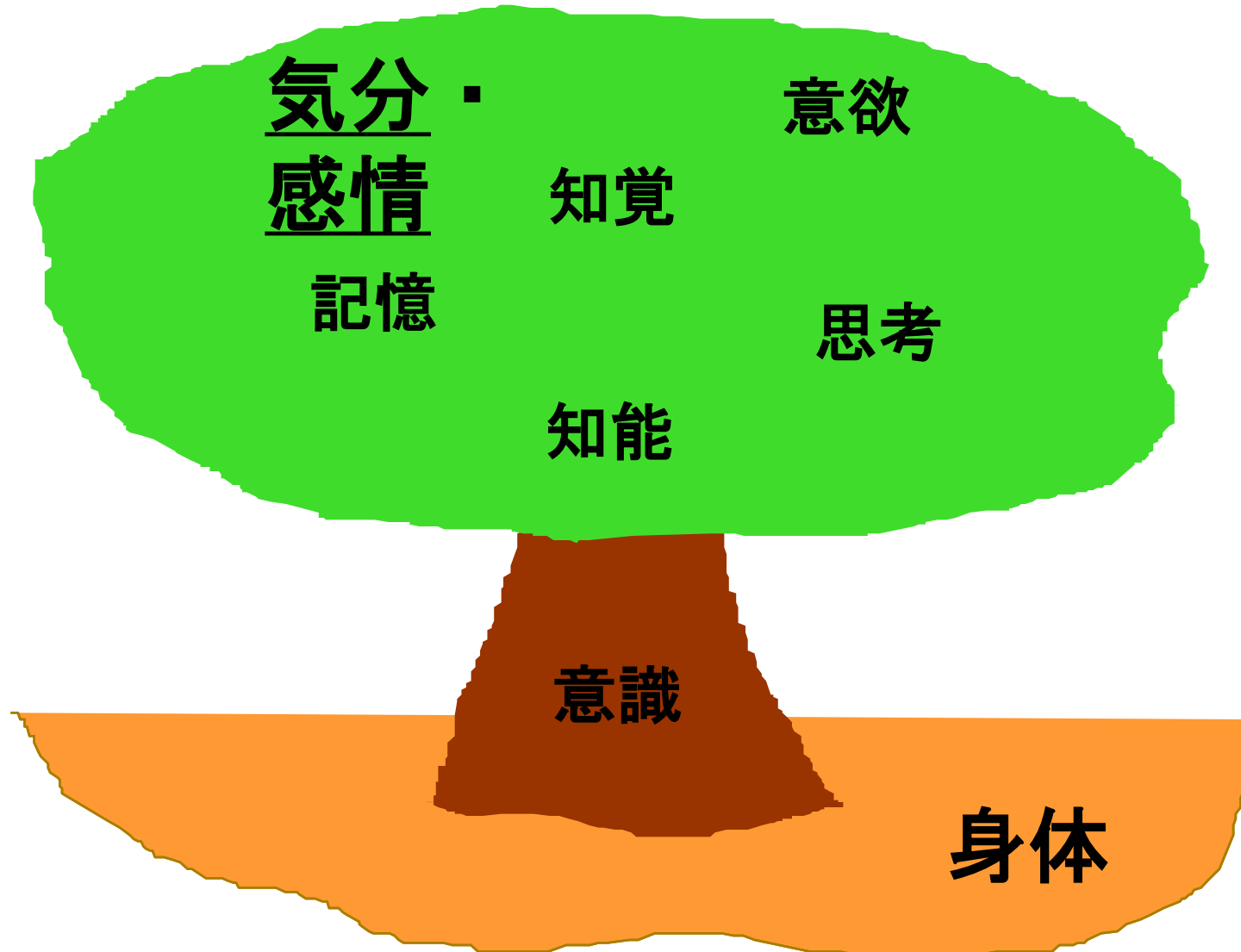
記銘力障害のこと（新しいことが記憶できない）

認知症*の初期症状はこちら



*認知症も重症になると過去の記憶も失われるようになる

ヒトの精神機能



感情・気分

北村俊則、精神・心理症状学ハンドブック

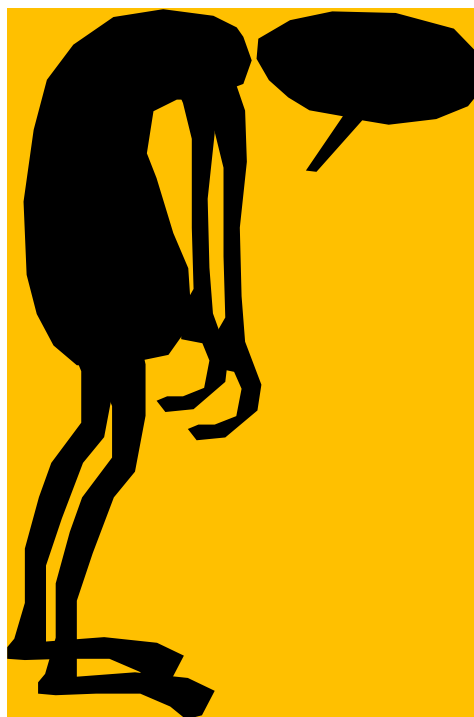
- ・ 感情 (emotion) : 「天気」に例えられる
一時的な反応性の主観的な気持ち (喜怒哀楽など)
- ・ 気分 (mood) : 「気候」に例えられる
持続的な感情 (不安、うつ、躁など)

気分の障害

不安
(不安状態)



抑うつ気分
(抑うつ状態)



爽快気分
(躁状態)



不安と抑うつ

- ・ 不安が起こる状況：不確実な脅威への直面
- ・ 抑うつが起こる状況：喪失、喪失の予期

これを医療の現場に当てはめてみると-----

医療情報の不足・・・・・・・・不安
悪い知らせ（進行がんなど）の開示・・抑うつ

不安・抑うつと身体症状

北村俊則、1998 ; Kaplan、1994 ; Casper、1985

不安状態：呼吸困難、胸部圧迫感、動悸、口渇、
嘔気、胃部不快感、下痢、頻尿、めまい、
筋緊張、発汗、振るえ、頭痛、不眠など
(主として自律神経症状)

抑うつ状態：倦怠感、食欲低下、不眠、便秘
思考・集中力低下、性欲の低下など

注：しかし、医学的に説明がつかない身体症状を安易に
精神的なものと考えてはいけない

Covid-19（新型コロナウイルス）と人の心理状態

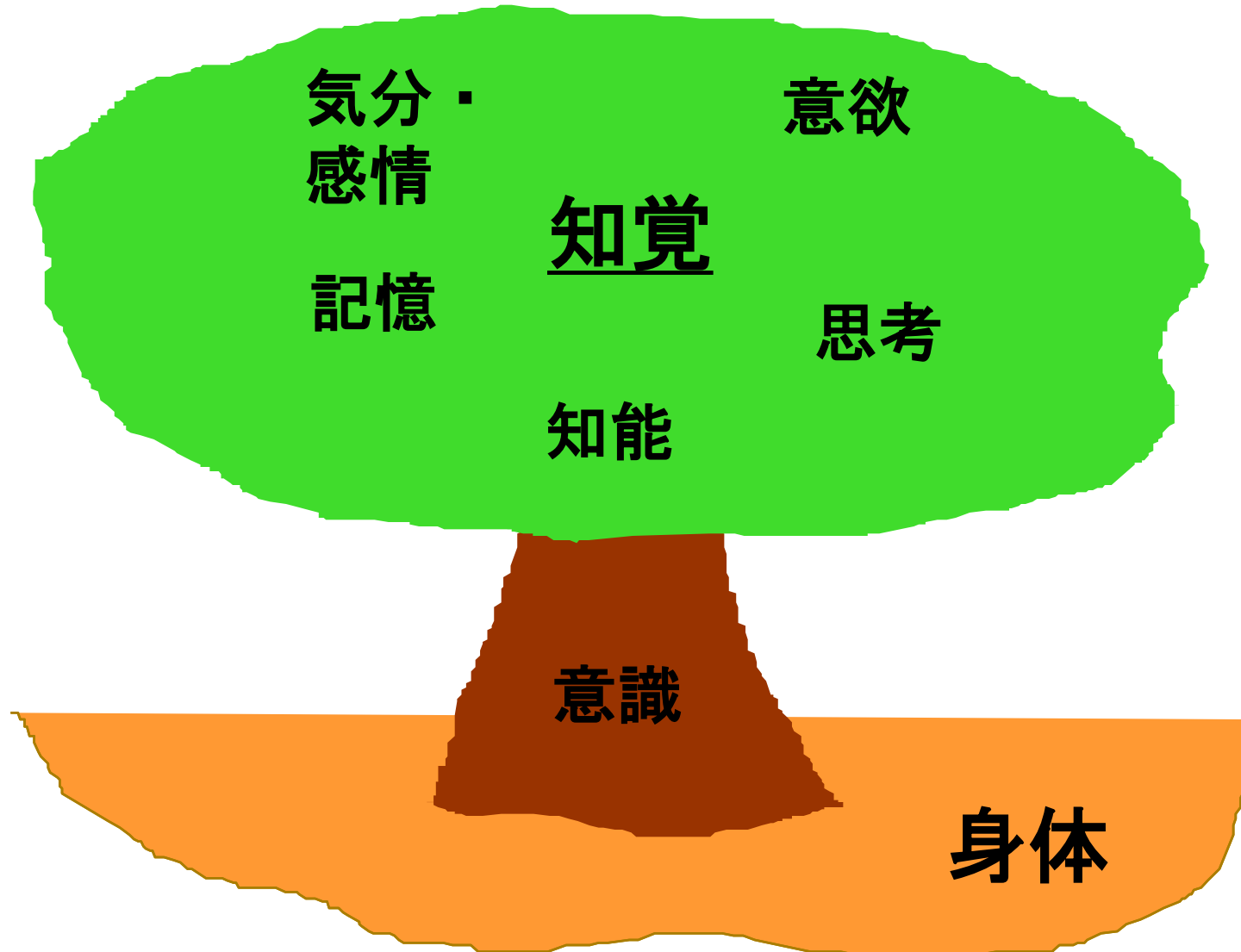
未知のウイルスであり、多くの人が**不安**を感じている

（不安は人間にとって不可欠であり有益な面もある[危険を知らせる警報]
→不安は誰もが感じる正常な心理的反応であることを知る）

学業・仕事ができない、役割が果たせない、収入を失う・倒産する、
人とのつながりを失う、家族や友人を失う

→これらは喪失であり、**抑うつ**に陥る可能性もある

ヒトの精神機能



知覚とその障害

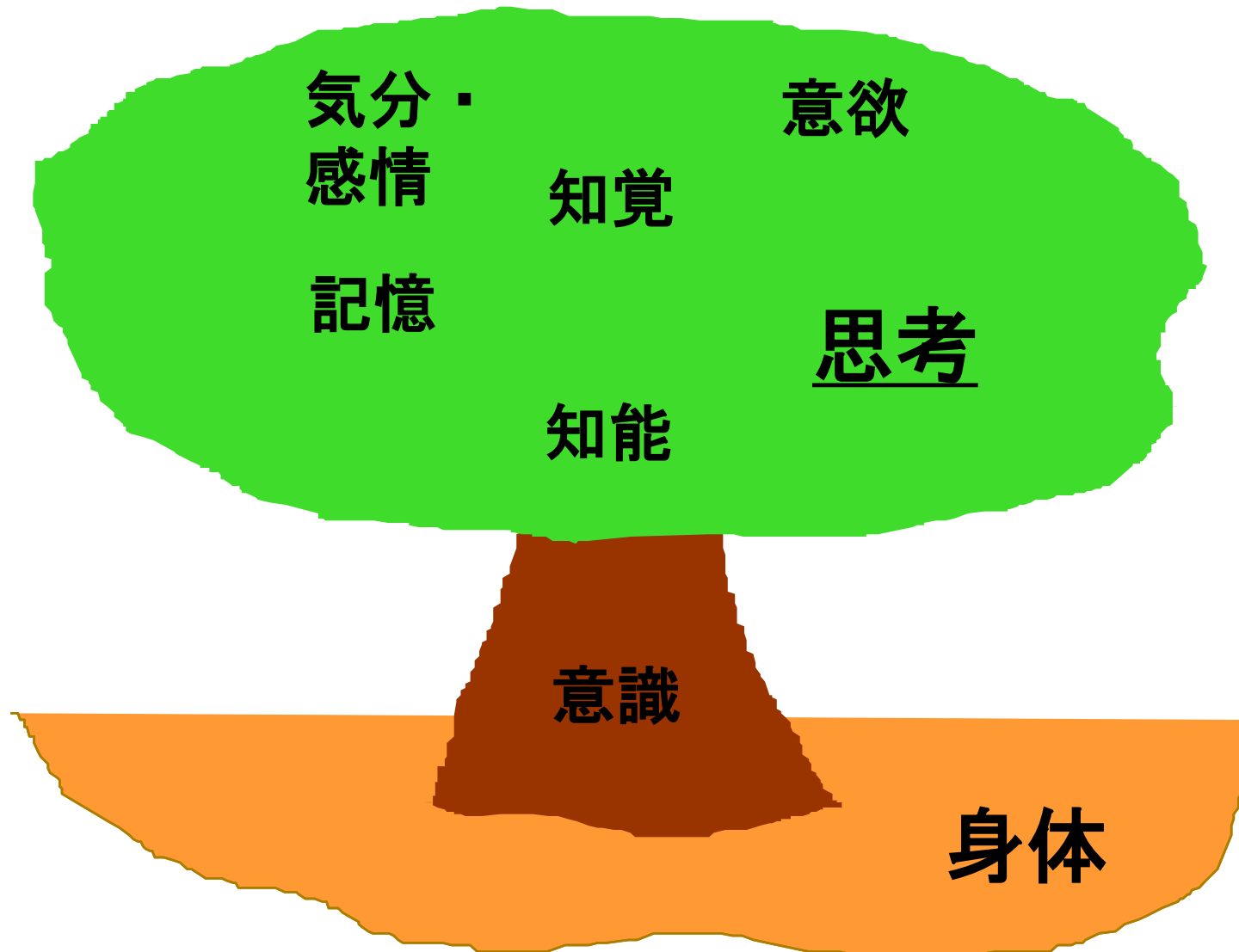
- 錯覚

「実際に存在する対象を間違って別のものと知覚すること」
－パレイドリア：天井のしみが人の顔に見える

- 幻覚

「実際には存在しない対象を存在するように知覚すること」
－幻聴
－幻視
－体感幻覚（セネストパチー）：脳が腐って動いている
－幻臭
－幻肢（幻肢痛：切断された足先に痛みを感じる）

ヒトの精神機能



思考とその異常

思考の異常

思考内容の異常

思考形式の異常

思路の異常

思考の体験様式の異常

思考内容の障害

- **妄想**：間違っていて、確信され、訂正不可能。かつ文化的に説明できない
- 妄想の分類
 - **一次妄想**（発生機序を心理学的に了解できない）
 - 妄想気分：世界没落体験「この世の終わりが来る」など
 - 妄想着想：突然の思いつき「自分は神の子である」
 - 妄想知覚：ある知覚に対する特別な意味づけ
「犬が前足をあげたのは会社が倒産する知らせだ」
 - **二次妄想**（心理学的に了解可能）
「妻は浮気をしている」

妄想の内容による分類

- **被害関係妄想**（統合失調症に多い）
：誰かに狙われている
- **微小妄想**（うつ病に多い）
 - － 貧困妄想：貧しくて入院費も払えない
 - － 罪業妄想：取り返しのつかない過ちを犯してしまった
 - － 心気妄想：不治の病にかかってしまい、もう助からない
- **誇大妄想**（躁病に多い）
：自分は天才だ、将来大金持ちになる

思考とその異常

思考の異常

思考内容の異常

思考形式の異常

思路の異常

思考の体験様式の異常

思路の障害

- **観念奔逸**：次から次へと新たな考えが思いつき、結果的にまとまりが欠けてしまう
- **思考制止、思考抑制**：考えのすすみ方にブレーキがかかったように遅くなる
- **思考途絶**：思考の流れが突然一時的に止まる
- **連合弛緩、滅裂思考、言葉のサラダ**：個々の考えに論理的な結びつきが失われる
- **迂遠**：回りくどく冗長
- **保続**：いったん浮かんだ考えが持続し、思考が次の過程にすすめない

思考とその異常

思考の異常

思考内容の異常

思考形式の異常

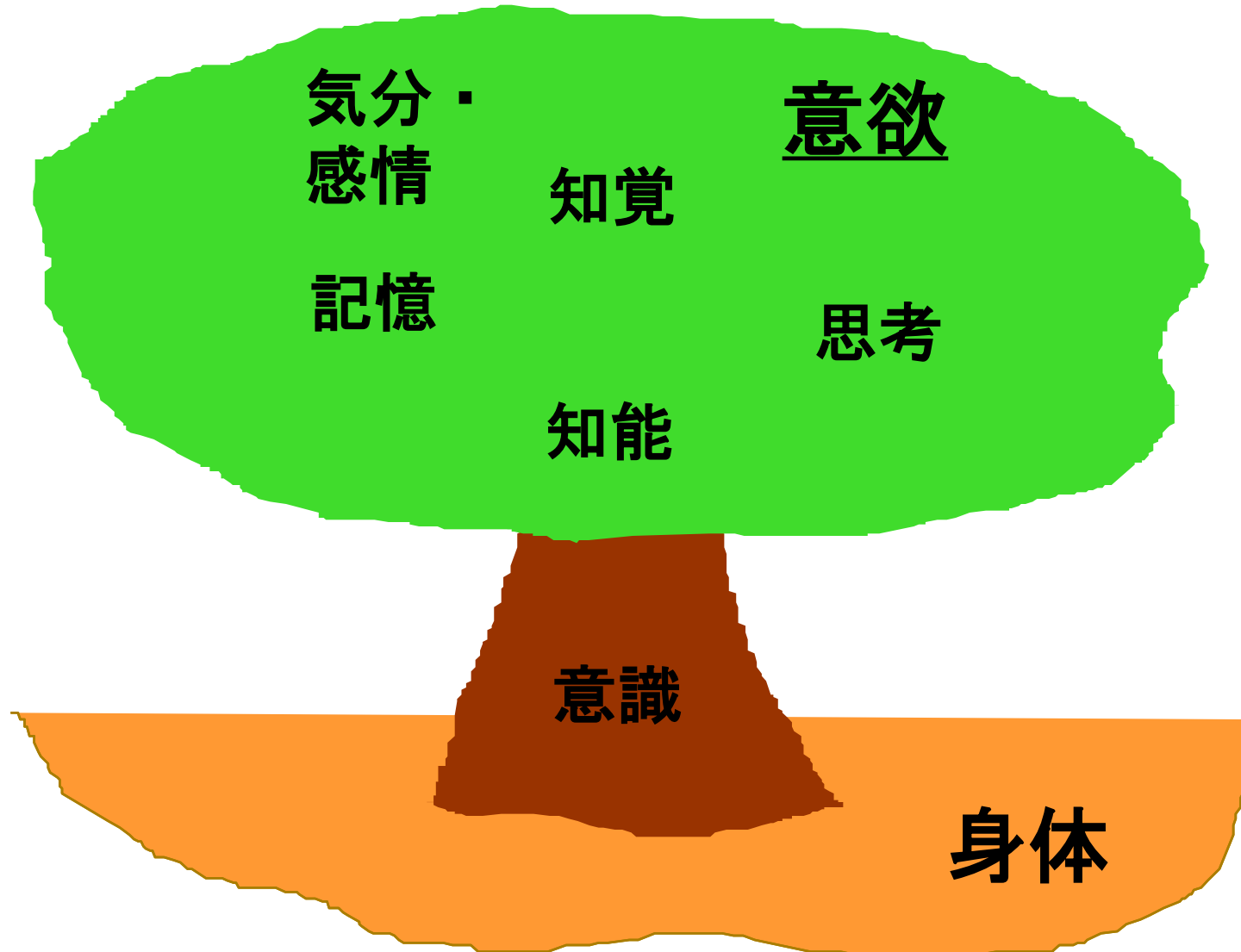
思路の異常

思考の体験様式の異常

思考の体験様式の障害

- **させられ体験（作為体験）**
 - － 思考吹入：他人に考えを吹き込まれる
 - － 思考奪取：自分の考えが抜き取られる
 - － 思考伝播：自分の考えが他人に伝わる
 - － 思考察知：自分の考えが他人に筒抜け
- **強迫観念**
 - － 自分で不合理（ばかばかしい）と知っていながら
払いのけることの出来ない考え
例：箸で自分を傷つけてしまうのではないかと恐れる

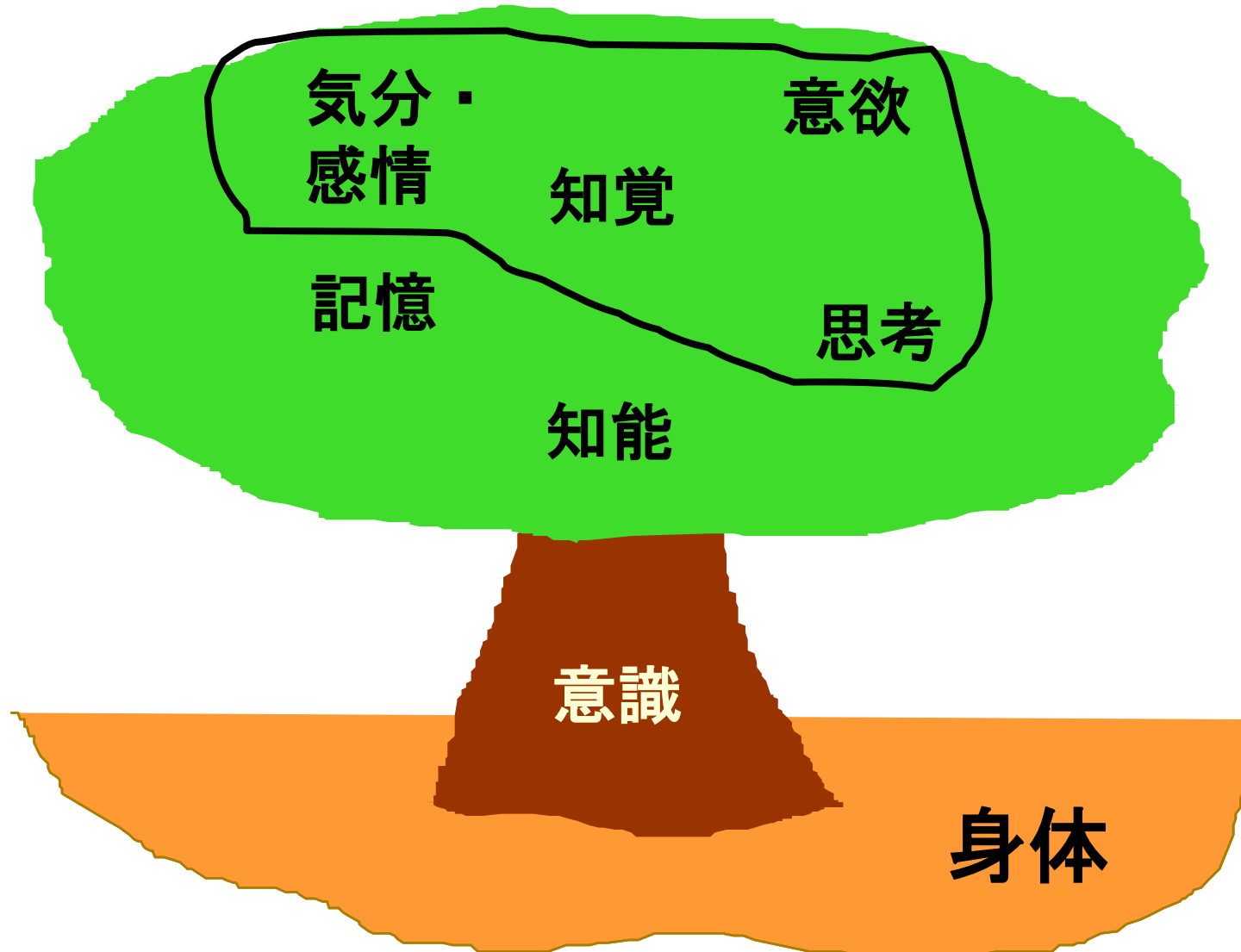
ヒトの精神機能



意欲

- 意欲：行動の元になる内的なエネルギー
- 意欲の量的障害
 - － ↑（亢進）
 - 躁病性興奮、行為心迫：思いついたことを行動に移し続ける
 - 緊張病性興奮：行動に目的がなく、周囲の状況とは無関係に行動量が増加する
 - － ↓（低下）
 - 昏迷：意識は清明であるにも関わらず、意欲が過度に低下し、外界の刺激にまったく反応しなくなった状態

ヒトの精神機能



気質、性格、人格

- 個人に特徴的な感じ方、考え方、行動のパターン
- 気質temperament
 - 体質的、身体的な要素が強い用語
- 人格personality、性格character

精神医学総論

- 精神症状学
- 疾病分類学

疾病分類学 (Nosology)

精神科診察診断学 古川壽亮、神庭重信編 医学書院

なぜ分類をするのか？

一人一人の患者には3つの特徴がある

1. 全ての患者と共通の特徴（例：苦しんでいる）

→これが優先なら分類をする必要がない（Rogersなどはこの立場）

2. **一部の患者と共通だが、他の患者とは共通でない特徴**（例：妄想）

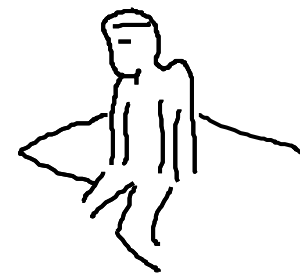
→これに気づき、特徴的な単位として認識することが疾病分類であり、これに名前をつけること（**DSMなど**）で共通言語となり、治療をよりよいものに変えていくこと（つまり研究）も可能となる。

しかし、逆にいうとそれだけのものともいえる。また、これからも変化する。

3. その患者だけに**固有の特徴**（例：7-8歳頃、養父から虐待を受けて以降変調）

→これが優先なら分類は不可能（過去の患者と今日診る患者には共通点がないため）

学問も成立しない。しかし、個別的な治療に生かす際には重要な情報となる



精神科診断に際しての注意事項

- 診断は今回エピソードの**最重症時**に着目。また**縦断的**に行う。
（例 現在軽いうつ状態→うつ病、双極性障害のいずれの可能性もあり）
- 精神機能を対象にしているため、患者に起きている現象を正しく表現することが重要（これが**精神症状学**であり基本的な精神病理学である）
- 精神疾患には疾患特異的な症状がない
（例 DSM-IVでは統合失調症に優勢な症状として位置づけられていたシュナイダーの1級症状[奇異な妄想、説明幻聴、対話性の幻聴]がDSM-5ではなくなった）
- **DSM診断は臨床診断の出発点**に過ぎない。
治療に生かすにはDSM診断のみではまったく不十分であり、患者固有の特徴を評価し、**診断の定式化（Formulation）**を行うことが重要

精神疾患の分類（DSM-5）

2013年5月改訂

DSM-5への変更点

I. 神経発達症群/神経発達障害群

知的能力障害、自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害、注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害など **自閉症スペクトラム障害としてまとめられる**

II. 統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害

III. 双極性障害および関連障害群 **双極性障害が独立**

IV. 抑うつ障害群

うつ病（DSM-5）/大うつ病性障害、
持続性抑うつ障害（気分変調症）など

V. 不安症群/不安障害群

VI. 強迫症および関連障害群/強迫性障害および関連障害群

醜形恐怖症/身体醜形障害など **強迫性障害、**

VII. 心的外傷およびストレス因関連障害群 **外傷後ストレス障害が独立**

心的外傷後ストレス障害、適応障害など

VIII. 解離症群/解離性障害群

IX. 身体症状症および関連症群

身体表現性障害が
身体症状症へ名称変更

身体症状症、病氣不安症、変換症/転換性障害など

X. 食行動障害および摂食障害群

神経性やせ症/神経性無食欲症、神経性過食症/神経性大食症、
過食性障害など

XI. 排泄症群

XII. 睡眠覚醒障害群

XIII. 性機能不全群

XIV. 性別違和

XV. 秩序破壊的・衝動制御・素行症群

XVI. 物質関連障害および嗜癖性障害群

XVII. 神経認知障害群

せん妄、認知症、軽度認知障害など

軽度認知障害

XVIII. パーソナリティ障害群

(Mild neurocognitive disorder)

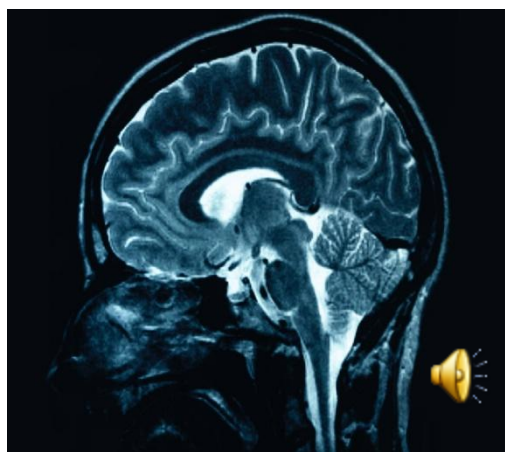
XIX. パラフィリア障害群

が加わる

精神医学の諸分野

• Natural sciences系

- 神経生化学
- 精神生理学
- 脳画像
- 神経心理学
- 精神薬理学
- 分子遺伝学



• Social sciences系

- 社会精神医学
- 比較文化精神医学
- 司法精神医学
- 集団遺伝学



• Human sciences系

- 精神病理学
- 認知行動科学
- 健康心理学
- サイコオンコロジー



• 対象ごとの分類

- 児童精神医学
- 老年精神医学



精神医学とは？

- 統合失調症発症に関連する脳内のメカニズムは何か？
 - うつ病に対してはどんな精神療法が有効か？
 - 認知症の患者さんの生活の質を向上させるにはどのような方法があるか？
 - 自殺の生物学的、心理学的メカニズムは何か？
 - ひきこもりはなぜ起こるのか？
 - 終末期疾患の患者さんの心のケアとして有効な方法は何か？
 - 重い病気を患った患者さんのご家族に対しての有効なケアは何か？
- etc.

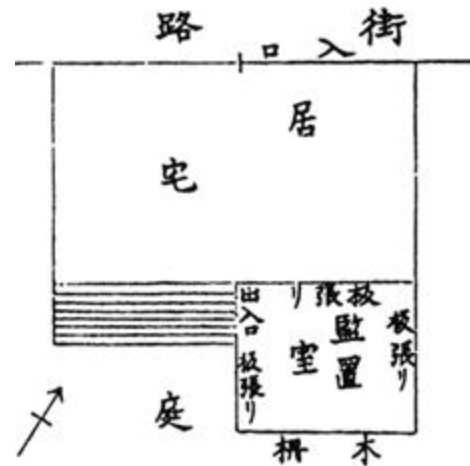
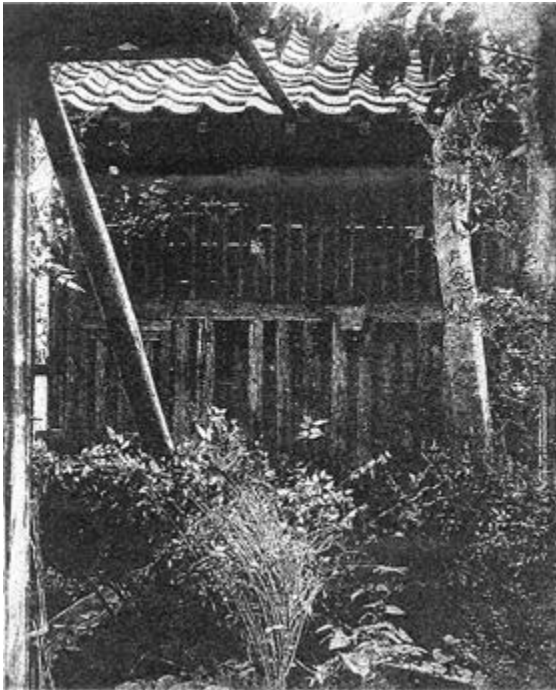
死にゆく患者の心理的プロセス

E. キューブラー・ロス *死ぬ瞬間 (1969)*

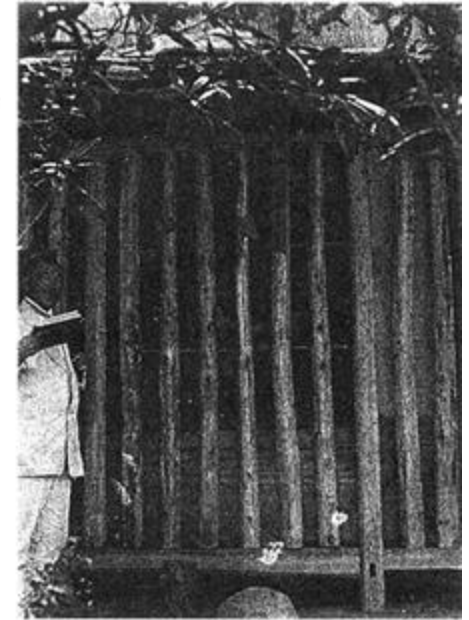
否認→怒り→取り引き→抑うつ→受容

これは何でしょうか？

座敷牢（日本は昔、精神疾患患者の私宅監置を認めていた）



呉・樫田：第64例付図



ヒント：「わが国十何万の精神病者はこの病を受けたるの不幸のほか
この国に生まれたるの不幸を重ねるものというべし」

呉秀三（東大精神科教授）1918年

ある進行がん患者とのコミュニケーション

鷲田清一 聴くことのか ちくま学芸文庫

△ 私はもうダメなのでしょうか？

- A. そんなこと言わないで、もっとがんばりましょうよ
- B. そんなこと心配しなくてもいいんですよ
- C. どうしてそんな気持ちになるんですか？
- D. これだけ痛みがあると、そんな気持ちにもなりますね
- E. もうダメなんだな――と、そんな気がするんですね
- F. すみません、今忙しいので、後で来ます

あなたならどのようにケアしますか？

推薦参考書

- 標準精神医学 医学書院
- カプラン・サドック「臨床精神医学テキスト」、
医学書院

最後に

こころの病に関して理解を深めていただくことに加え、病を持った人の心にも配慮できる、またこころが関係する様々な医学的状況に適切に対応できる医師になっていただきたいと思います。